CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Fiche IV - B - 3

Version 2.0.0

Du 01/09/2026

CONDUITE À TENIR

Rédacteurs :

Daniel MEYRAN

Julien PAPOZ

Amputation ou arrachement complet d'une partie du corps

DÉFINITION

On parle d'amputation ou arrachement :

- complet lorsqu'une partie externe du corps (doigt, main, bras, etc.) ou des tissus mous (joue, nez, oreille, organes génitaux, etc.) est entièrement séparée du corps, sans aucune liaison résiduelle telle que muscles, tendons ou peau.
- partiel lorsque des connexions résiduelles (muscles, vaisseaux sanguins, peau) sont conservées, ce qui augmentent les possibilités de réparation chirurgicale et de récupération fonctionnelle.

CAUSES

Les amputations ou arrachements d'une partie du corps touchent surtout les jeunes enfants et les adultes. Ils sont toujours d'origine traumatique et surviennent, le plus souvent, après un accident domestique ou un accident du travail.

CONSÉQUENCES

Les amputations ou arrachements complets de parties externes du corps sont des événements traumatiques pouvant entraîner des séquelles physiques et psychologiques majeures.

Le premier risque d'une amputation ou d'un arrachement d'une partie du corps est l'hémorragie externe dont la survenue peut être retardée de plusieurs minutes. Les conséquences sont les mêmes que pour toute hémorragie externe et son contrôle reste la priorité des premiers secours.

Il est parfois possible de « réimplanter » chirurgicalement une partie de corps amputée ou arrachée. Cette réimplantation dépend étroitement de la qualité de la prise en charge initiale de la partie sectionnée. Le temps d'ischémie constitue un facteur décisif pour la réussite de la réimplantation et une conservation correcte par refroidissement en augmente significativement les chances.

BILAN

La section de membre est le plus souvent évidente et constatée dès le début du bilan d'urgence vitale (Fiche III-C) (fig. 1).

Parfois, cette section est masquée si la victime est incarcérée ou si elle est partiellement ensevelie.



Figure 1 : section de membre

PRINCIPES DE L'ACTION

- Arrêter immédiatement l'hémorragie pour limiter la perte de sang.
- Lutter contre la détresse circulatoire.
- Retrouver et préserver le membre sectionné (réimplantation chirurgicale du membre amputé possible).
- Transporter avec la victime et la partie du corps amputée ou arrachée.

CONDUITE À TENIR

- Appliquer la conduite à tenir adaptée et réaliser en priorité les gestes d'urgence qui s'imposent notamment, arrêter l'hémorragie externe immédiatement (Fiche IV-B-2)
- En l'absence de saignement, réaliser un pansement compressif en s'aidant d'une gaze imbibée d'une substance hémostatique si possible (Fiches V-C-6 et V-C-24).
- Demander un renfort médical en urgence absolue pour toute section de membre complète qui siège au-dessus du coude ou au-dessus du genou (Fiche III-F).
- Conditionner la partie du corps amputée ou arrachée (Fiche V-E-3) ;
- Poursuivre le bilan et surveiller attentivement la circulation.